

TEMA 3.27 • OBSTETRICIA

Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE)

PERFIL EUNACOM 2.01.2.021
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE)

Importancia

- Solo riesgo fetal (no riesgo materno)
- Puede producir muerte fetal intrauterina
- Manejo en policlínico de alto riesgo obstétrico

Clínica

TABLA 3.27.1: CARACTERÍSTICA VS DETALLE	
CARACTERÍSTICA	DETALLE
EG	2º–3er trimestre (habitualmente > 30 semanas)
Síntoma cardinal	Prurito palmoplantar nocturno (más intenso de noche; puede ser generalizado)
Sin rash ni lesiones cutáneas	Si hay lesiones → pensar en otras causas (sarna, etc.)
Puede haber	Náuseas, astenia, ictericia (criterio de severidad)

Diagnóstico

- Clínico: prurito palmoplantar nocturno en embarazada = diagnóstico presuntivo
- Laboratorio confirmatorio:
 - - Ácidos biliares elevados → marcador más importante
 - - Bilirrubina y fosfatasas alcalinas pueden elevarse (colestasis)
 - - Transaminasas levemente elevadas
 - - Ácidos biliares muy altos → criterio de severidad

Tratamiento

TABLA 3.27.2: MEDIDA VS DETALLE	
MEDIDA	DETALLE
Ácido ursodesoxicólico (AUDC)	Tratamiento sintomático — disminuye prurito; posiblemente mejora riesgo fetal
Corticoides antenatales	Indicados (riesgo de parto antes de 34 sem)
Interrupción	Tratamiento definitivo

Momento de interrupción

TABLA 3.27.3: SEVERIDAD VS INTERRUPCIÓN	
SEVERIDAD	INTERRUPTIÓN
CIE no severa	36–38 semanas

| CIE severa (ictericia, ácidos biliares muy altos, prurito intenso) |
36 semanas |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Respecto a Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Importancia
- Clínica
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Momento de interrupción
- alto riesgo obstétrico
- | 2º–3er trimestre (habitualmente > 30 semanas) | |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COLESTASIS INTRAHEPÁTICA DEL EMBARAZO (CIE))**PREGUNTA 1**

Respecto a Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Colestasis Intrahepática del Embarazo (CIE). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: COLESTASIS INTRAHEPÁTICA DEL EMBARAZO (CIE)